TMO EPM · EPISÓDIO 92 · RESUMO DO JOURNAL CLUB

Lenalidomida para sempre ou por 2 anos?

Manutenção contínua ou de duração fixa no mieloma múltiplo recém-diagnosticado de risco padrão — ENDURANCE, Kumar S et al. (N Engl J Med 2026)

O estudo

Ensaio de **fase 3, aberto** (ECOG-ACRIN). Mieloma recém-diagnosticado de **risco padrão** (sem del17p, t(14;16) ou t(14;20) no FISH), **sem transplante autólogo de entrada**. Etapa 1: indução com **KRd ou VRd**. Etapa 2: quem terminou a indução foi randomizado 1:1 para lenalidomida **até a progressão** ou **por 2 anos**. Idade mediana 65 anos. Desfecho primário: **sobrevida global**, com poder de 80% para detectar aumento de 50% na mediana (de 5 para 7,5 anos).

1.087	516	260	256	86 m
na indução	randomizados	contínua	por 2 anos	seguimento mediano

Resultados principais

	Contínua (n = 260)	2 anos (n = 256)	Diferença
Sobrevida global em 7 anos	68,6%	69,0%	−0,4 ponto · IC 95% −9,0 a 8,3 · p = 0,93
Mortes	80	80	—
PFS mediana	42,5 meses	38,9 meses	—
PFS em 7 anos	36,1%	29,7%	6,4 pontos · IC 95% −2,6 a 15,4
EA não hematológico grau ≥3	**48,2%**	31,5%	mais com a contínua
Modificação de dose por EA	62,0%	44,5%	—
Segunda neoplasia em 5 anos*	11,2%	8,3%	—

* Incidência cumulativa, excluindo câncer de pele não melanoma. Os intervalos de confiança da PFS não foram ajustados para multiplicidade — o próprio artigo pede que não sejam usados para inferir efeito definitivo.

Quanto tempo de lenalidomida, de fato

- Média de ciclos: **38,5** na contínua e **18,2** no braço de 2 anos; 56,7% do braço fixo completaram os 2 anos.
- Na contínua, 42,0% pararam por progressão. Depois dos 2 anos, interromperam por progressão (17,3%), evento adverso (9,0%) ou decisão do paciente (4,3%).

© 2026 TMO EPM · reprodução somente com autorização do canal · EPM-Unifesp / Hospital Nove de Julho

Leitura crítica

- **População restrita:** só risco padrão e só quem não ia para transplante de entrada — alto risco ficou de fora.
- **Indução de outra época:** KRd ou VRd, sem anti-CD38; hoje a quádrupla é o padrão para boa parte dos pacientes.
- **Sem doença residual mensurável (DRM)** para guiar a parada — a pergunta "quem pode parar?" fica sem marcador.
- **Estudo aberto** e com menos mortes do que o planejado no cálculo do poder (160 observadas, frente a 204 previstas).
- **Desfecho certo:** sobrevida global como primário é raro em manutenção e responde à pergunta que importa para o paciente.

O que dá para levar

- No risco padrão sem transplante de entrada, parar a lenalidomida em 2 anos deu a **mesma sobrevida global**.
- Manter cobra em toxicidade: mais eventos adversos graves e mais ajuste de dose.
- A PFS foi numericamente maior com a contínua, sem tradução em sobrevida.
- Na discussão do episódio: a DRM pode ajudar a decidir quem para com segurança — ainda sem dado deste estudo.

Referência

Kumar S, Jacobus S, Cohen A, et al. Continuous or Fixed-Duration Maintenance Therapy in Multiple Myeloma. N Engl J Med 2026;395:221-32. doi:10.1056/NEJMoa2600157 · ENDURANCE, ClinicalTrials.gov NCT01863550.

Ouça o episódio 92

Apresentação: Israelita Sussuarana · Discussão: Carol Marques, Karine Vicenzi, Lívia Monteiro, Rafael Faust, Pedro Moraes e Vinícius Molla

▶ YouTube: **https://youtu.be/5mUAJN2S8M8**

🎧 Spotify: **https://open.spotify.com/episode/4753YmGiBTenlE93wUpQgZ**

📸 Instagram: **@tmoepm**

Material educativo, preparado a partir do artigo citado. Não substitui o julgamento clínico.

© 2026 TMO EPM · resumo do episódio 92 · reprodução ou uso em aulas e materiais somente com autorização (@tmoepm)